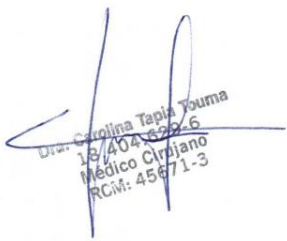


	PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMUNA DE PERALILLO	Código:	GCL 1.5
		Fecha:	Julio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2028
		Página:	Página 1 de 19

PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMUNA DE PERALILLO

**Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario,
CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo**

Elaborado por: Dra. Carolina Tapia T. Dra. Laura Pérez L. Dra. Karolan Verdugo M.	Revisado por: EU María José Solís L.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Médicas EDF CESFAM Peralillo.	Cargo: Referente Técnico Unidad de Calidad.	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 17 de Julio 2023	Fecha: 20 de Julio 2023	Fecha: 26 de Julio 2023
Firma: 	Firma: 	Firma: 

I. INTRODUCCIÓN

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es una emergencia médica potencialmente reversible; consiste en el cese de la actividad mecánica cardíaca y respiratoria. El conjunto de medidas aplicadas para revertirlo se denomina reanimación cardiopulmonar (RCP). Se distinguen dos niveles: soporte vital básico y soporte vital avanzado.

El inicio de RCP precoz es una de las medidas que ha demostrado mejorar la supervivencia del paro cardíaco, por lo que es de extrema relevancia que, como trabajadores de la salud, estemos capacitados para realizar esta actividad de forma adecuada.

II. PROPÓSITO

Ser un equipo de salud competente para enfrentar un paro cardiorespiratorio en nuestro centro.

III. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras en el contexto de quien sufre un paro cardio-respiratorio, tanto adultos como pediátricos, que ocurran dentro de nuestro establecimiento.

b. Objetivos específicos

- Estandarizar acciones de respuesta frente a PCR, considerando la actual evidencia.
- Determinar prioridades en la organización y en los flujos de comunicación mejorando la respuesta frente al paro cardiopulmonar.
- Preparar al paciente y al equipo de forma eficiente previo al traslado del afectado al establecimiento de referencia de mayor complejidad médico quirúrgica.

IV. ALCANCE

El presente protocolo está dirigido a todos los funcionarios, tanto clínicos, administrativos y de servicio, que se desempeñan en los centros de salud de la comuna de Peralillo: CESFAM Peralillo, Postas de Salud Rural y Estación Médico Rural.

V. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- a. **Médico**: Liderar las acciones frente al PCR, regular el funcionamiento óptimo del equipo en el RCP y entregar indicaciones de tratamiento, según lo detallado en el desarrollo del presente protocolo.
- b. **Encargado de carro de paro SUR**: Supervisar que estén los fármacos e insumos indicados por OA para asegurar la RCP.
- c. **Profesionales y TENS**: Brindar apoyo en la atención, teniendo cada uno un rol particular en la actividad de RCP.
- d. **Referente administrativo y técnico SUR**: Responsables de difundir y supervisar el cumplimiento de la aplicación del presente protocolo.

VI. DEFINICIONES

- a. **Paro cardiorrespiratorio (PCR)**: Situación clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y/o cardiocirculatoria espontáneas, produciendo una disminución brusca del aporte de oxígeno pudiendo conducir a lesiones irreversibles.
- b. **Reanimadores**: Personal de salud, capacitado en resucitación cardiopulmonar. Grupo de personas que responden a una situación de emergencia o paro cardiorrespiratorio.
- c. **Reanimación Cardiopulmonar (RCP)**: Es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir un PCR, logrando obtener flujo sanguíneo eficiente.
- d. **Flujograma RCP**: Esquema que clarifica puntos de RCP dentro del establecimiento, sus flujos de coordinación, y canales de comunicación.
- e. **Algoritmo RCP**: figura gráfica que muestra el flujo de atención y clarifica los medicamentos a administrar y acciones a realizar frente a un paro cardiorrespiratorio.
- f. **Cadena de Sobrevivencia**: Las acciones enlazadas que se realizan en un paro cardíaco con el fin de lograr la supervivencia del paciente.

- g. **Compresiones Torácicas:** Movimientos que se realizan en el centro del tórax del paciente, con las manos entrelazadas, los codos completamente extendidos y las rodillas en ángulo recto a nivel de la persona reanimada.
- h. **Ventilaciones:** Corresponde al apoyo para ingresar aire a los pulmones.
- i. **Soporte Vital Básico:** Conjunto de conocimientos y habilidades para identificar a las víctimas de paro cardíaco y/o respiratorio, alertar a los sistemas de emergencia y realizar una asistencia de las funciones respiratoria y circulatoria.
- j. **Soporte Vital Avanzado:** Conjunto de técnicas avanzadas y maniobras dirigidas a proporcionar el tratamiento definitivo en las situaciones de PCR en unidades más sofisticadas y previstas para los cuidados del paciente.
- k. **Escena segura:** Se refiere a que el área física donde se encuentre la víctima no signifique un riesgo para el reanimador. Una vez verificada la seguridad se procederá a realizar la evaluación y reanimación del usuario.
- l. **Código azul:** estrategia de emergencia protocolizada en nuestro centro.
- m. **Siglas:**
 - **PCR:** Paro Cardio Respiratorio
 - **RCP:** Reanimación Cardio Pulmonar
 - **SVB:** Soporte vital Básico
 - **SVA:** Soporte vital avanzado
 - **DEA:** Desfibrilador Externo Automático

VII. DESARROLLO

1) Reconocimiento de un PCR:

El reconocimiento inmediato del paro es el paso clave para la activación del sistema de respuesta de emergencias y el inicio precoz del tratamiento. Este reconocimiento debe ir seguido de una rápida verificación (no más de 10 segundos idealmente) de si hay pulso o no para comenzar de inmediato la RCP.

Signos y síntomas:

- Pérdida de conciencia.
- Ausencia de pulso.
- Ausencia de respiración (apnea) o respiración anormal o agónica (Gaspings).

a. Confirmar la seguridad de la escena: Asegurar que el entorno sea seguro para el o los reanimadores y para la víctima.

b. Verificar la capacidad de respuesta: Si la víctima no responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca, luego de esto, activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un equipo móvil o delegando a un tercero, recordar dar órdenes claras y precisas. Por ejemplo, llamar al 131 (ambulancias), traer desfibrilador automático, y en nuestro caso activar protocolo de código azul de nuestro establecimiento.

c. Reconocimiento de Paro Cardiorrespiratorio o Respiratorio: Consta de tres pilares fundamentales y no debe tomar más de 10 segundos en su evaluación.

- *Comprobar estado de consciencia:* Se puede evaluar con preguntas simples, como ¿Está usted bien? O en caso de falta de respuesta verbal, acudir a maniobra de dolor cómo aplicar presión con los nudillos sobre el esternón.
- *Comprobar ventilaciones:* Se debe observar movimientos respiratorios, sentir elevación torácica y escuchar el flujo de aire a través de las vías respiratorias altas.
- *Comprobar pulsos:* Se deben buscar pulsos centrales como el pulso carotídeo, para lo cual se debe palpar con los dedos índice y medio de la mano izquierda en dirección a la columna, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo derecho (figura 1). También se podría evaluar el pulso femoral, bajo el ligamento inguinal hacia medial (figura 2). Esta evaluación no debe extenderse más de 10 segundos, no se debe intentar buscar pulsos periféricos y ante la duda recordar que en general no somos buenos buscando pulsos, por lo que se siempre en caso de no encontrarlo se debería interpretar como ausencia.

En caso de que exista compromiso de conciencia, el paciente no respira o sólo jadea y no existe palpación certera de pulso, se realiza el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio y se prosigue con el manejo para realizar RCP. Por otro lado, si el paciente, presenta compromiso de conciencia, tiene respiración ausente o no respira con normalidad, pero presenta pulso, realizamos el diagnóstico de paro respiratorio y se procede a brindar ventilaciones de rescate.



Figura 1: búsqueda de pulso carotídeo

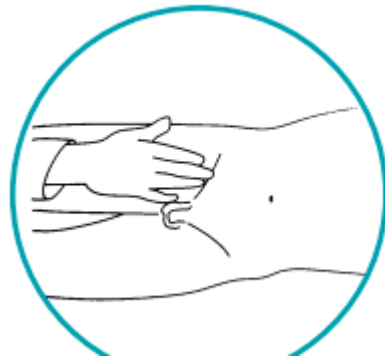


Figura 2: búsqueda de pulso femoral

2) Soporte vital básico (SVB)

El soporte vital básico corresponde a la aproximación inicial del paciente que se encuentra en un Paro Cardiorrespiratorio.

Determinar las prioridades de cuándo llamar primero y reanimar después, va a depender de la edad del paciente, la eventual causa de paro cardiorrespiratorio y número de reanimadores.



Figura 3: Cadena de supervivencia extrahospitalaria

Una vez identificado en PCR debe activarse el sistema de emergencia según el protocolo de código azul de nuestro establecimiento.

2.1) UN SOLO REANIMADOR

- *Adultos:* En el adulto, el 80-90% de los PCR no traumáticos son de causa cardíaca. Por lo tanto la posibilidad de sobrevivir va a depender de la desfibrilación temprana seguida de una reanimación cardiopulmonar oportuna. Por ello, la cadena de supervivencia del adulto pone el acento en la **desfibrilación inmediata** e incluye 5 eslabones:
 - a. **1er Eslabón:** “Llamar”. Una vez identificado el paro cardíaco, se debe activar el código azul y pedir ayuda.
 - b. **2do Eslabón:** “Reanimar”. Iniciar inmediatamente RCP precoz de calidad con énfasis en las compresiones torácicas minimizando las interrupciones, hasta llegada de equipo código azul.
 - c. **3er Eslabón:** “Desfibrilar”. Aplicar rápidamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA) o el desfibrilador que trae el equipo de salud SUR.
 - d. **4to Eslabón:** “Apoyo Vital Avanzado efectivo”, en nuestro caso realizado en SUR.
 - e. **5to Eslabón:** “Cuidados integrados post paro cardíaco” incluyendo acciones de estabilización a realizar en nuestro centro y posterior derivación a centro de mayor complejidad. Luego de identificar el PCR y activar el sistema de alerta y organización, se pueden iniciar las maniobras básicas de RCP. Si el operador inicial es solo uno, deberá aplicar sólo las compresiones torácicas de alta calidad, sin ventilación, hasta que llegue el resto del equipo.
- *Niños:* El paro cardiorrespiratorio en lactantes y niños se produce, la mayoría de las veces, por insuficiencia respiratoria progresiva o por shock. El paro respiratorio (apnea) a menudo precede al paro cardíaco. Por esta razón se propone iniciar RCP inmediatamente (2 minutos de RCP) y luego “llamar rápido” y activar sistema de emergencias en caso de que el paro no sea presenciado.

La cadena de supervivencia pediátrica consta de 5 eslabones:

- a. **1er Eslabón:** “Prevenir” las lesiones o paro cardiorrespiratorio.
- b. **2do Eslabón:** “Reanimar” por 2 minutos (cinco ciclos).
- c. **3er Eslabón:** “Llamar rápido”. Activas código azul y pedir ayuda.
- d. **4to Eslabón:** “Apoyo Vital Avanzado efectivo”, en nuestro caso realizado en SUR.
- e. **5to Eslabón:** “Cuidados integrados post paro cardíaco” incluyendo acciones de estabilización a realizar en nuestro centro y posterior derivación a centro de mayor complejidad.

Una diferencia fundamental entre la cadena de supervivencia prehospitalario del adulto y el pediátrico es el momento de cuándo llamar al 131. De allí los conceptos “llamar primero” versus “llamar rápido”:

- **“llame primero”** (llamar primero y luego iniciar RCP): Adulto, no asfixia, no trauma. **Niños y adolescentes con colapso presenciado.**
- **“llame rápido”** (una vez realizado 2 minutos de RCP o 5 ciclos, llame al 131): **Pediátrico (en caso de colapso no presenciado) y en presencia de asfixia.**

Para comprobar el pulso en **un lactante**, palpe o busque la arteria braquial (Figura 4).



Figura 4: búsqueda de arteria braquial en lactantes.

Para comprobar el pulso en un niño, palpe sobre la arteria carótida o femoral. (Figura 5 y 6)



Figura 5: búsqueda de arteria carótida en niños.

Figura 6: búsqueda de arteria femoral en niños.

2.2) DOS O MÁS REANIMADORES

Cuando existan dos o más reanimadores en el evento, uno debe iniciar RCP mientras que el otro integrante debe pedir ayuda y activar código azul.

3) COMPONENTES RCP EN ADULTOS

Los principales componentes de la reanimación cardiopulmonar son:

- a. **Compresiones torácicas:** La base de la reanimación cardiopulmonar son las compresiones cardiacas. Para una correcta llegada de sangre oxigenada al cerebro y órganos es necesario realizar compresiones de alta calidad, por lo que estas deben cumplir ciertas características.
- Las manos deben estar situadas la mitad inferior del esternón en el centro, se posiciona una mano sobre otra apoyando el talón de la mano en el tórax, la fuerza la ejerce el cuerpo, no se debe mover la cabeza ni doblar los codos.
 - La víctima siempre debe estar en una superficie plana y dura (figura 7).



Figura 7: compresiones en el adulto.

- *Relación compresión-ventilación:* debe ser de **30 compresiones y 2 ventilaciones**, independiente del número de reanimadores.

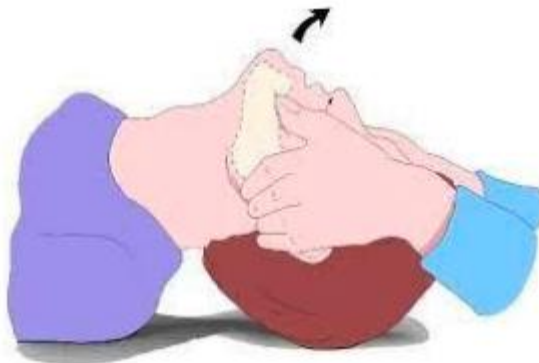
- *Frecuencia de las compresiones:* La frecuencia es de 100 a 120 compresiones en 1 minuto, independiente de edad y condición.
- *Profundidad de las compresiones:* Debe ser de 5 centímetros en el adulto.
- *Expansión completa del tórax:* Se debe permitir la expansión completa del tórax, después de cada compresión, sin mantener las manos ejerciendo fuerza sobre este.

b. Vía aérea: Para lograr ventilaciones efectivas la vía aérea se debe mantener permeable. Existen dos maniobras para lograr este objetivo:

- *Frente mentón:* para víctimas sin sospecha de lesión cervical (figura 8)



- *Tracción mandibular:* para víctimas con sospecha de lesión cervical (figura 9).



c. Ventilación:

- *Boca-boca:* esta técnica, no está recomendada, ya que no otorga protección hacia el auxiliador, queda a criterio personal realizar en el ambiente familiar o cercano.

- *Mascarilla de bolsillo y Barreras faciales*: corresponden a dispositivos de barrera que permiten el ingreso del aire, pero evitan que el reanimador se exponga a gérmenes y enfermedades infecciosas durante la reanimación (figura 10 y 11).



- *Bolsa - mascarilla* : este dispositivo aporta presión positiva, consta de una bolsa conectada a una mascarilla facial, puede ser suministrada con oxígeno o sin él (figura 12).



4) COMPONENTES RCP EN NIÑOS Y LACTANTES

- Compresiones de alta calidad en niños y lactantes:** Antes de iniciar las compresiones, se debe colocar al niño sobre una superficie dura y plana, en decúbito supino (de espaldas) y con la cabeza, cuello, tronco y extremidades bien alineados.
 - *Relación entre compresiones y ventilación:* En caso de existir un reanimador es la misma del adulto **30:2**.
En **caso de que existan 2 reanimadores el niño** debe recibir una relación de compresión/ventilación de **15:2**.
 - *Frecuencia de las compresiones:* Es la misma para todas las edades: 100-120 compresiones por minuto.

- *Profundidad de las compresiones:* Debe ser al menos $\frac{1}{3}$ del diámetro anteroposterior del tórax (5 cm). En el caso del lactante debe comprimir un tercio del tórax anteroposterior (aproximadamente 4 cm).
 - ** Recordar permitir la expansión torácica completa posterior a cada compresión con el objetivo de permitir que la sangre fluya hacia el corazón.
 - ** Al mismo tiempo, se debe reducir al mínimo las interrupciones entre compresiones, ya que un menor tiempo de interrupción se asocia a una probabilidad mayor de retorno a la circulación espontánea.
- *Técnica de compresión torácica:* Para la mayoría de los niños la técnica de compresión es la misma del adulto, en niños pequeños puede utilizar solo una mano para lograr la profundidad deseada.

Para el lactante puede utilizarse la técnica de dos dedos o la técnica de dos pulgares (preferible para dos reanimadores). En caso de que no logre la profundidad suficiente en cada compresión puede utilizar el talón de una mano (figura 13, 14 y 15).



Figura 13: Técnica de una mano para compresiones en niños.



Figura 14: Técnica de dos dedos para compresiones en lactantes con un reanimador.



Figura 15: Técnica de dos pulgares para compresiones en lactantes con dos reanimadores.

- b. **Ventilaciones en niños y lactantes:** En los niños y lactantes el PCR suele estar causado por problemas respiratorios, y por lo tanto es de vital importancia que niños y lactantes reciban compresiones y ventilación durante las maniobras de reanimación.
- Apertura de la vía aérea: Utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. En caso de que sospeche fractura cervical utilice la maniobra de tracción mandibular (figura 16).

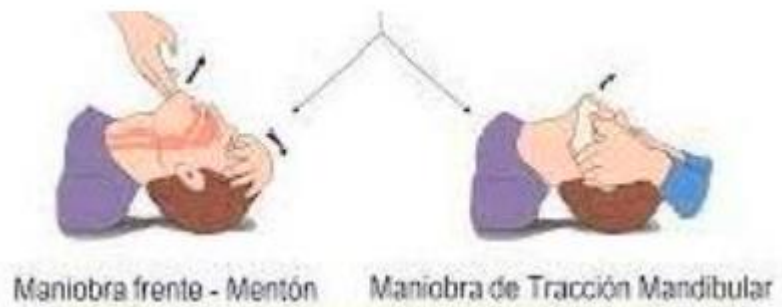
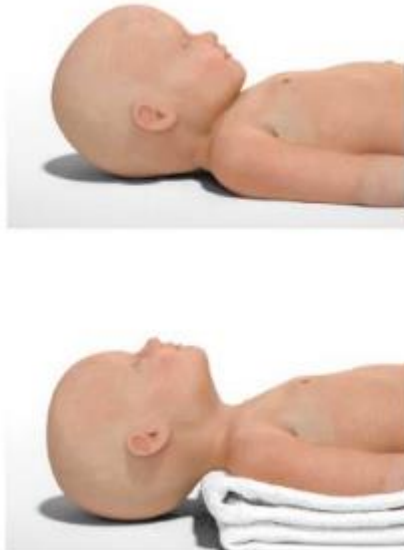


Figura 16: Apertura vía aérea en niños



Es importante mantener la cabeza del lactante en posición neutra para lograr la apertura de la vía aérea. El canal auditivo externo debe quedar a la altura de la parte superior del hombro del lactante

Figura 17: Apertura vía aérea en lactantes.

- Utilice un dispositivo de barrera para realizar ventilaciones en el niño (mascarilla facial o dispositivo bolsa-mascarilla). Se debe usar aquella que es adecuada al tamaño del niño o lactante (debe cubrir boca y nariz, sin cubrir ojos y/o extenderse por debajo del borde inferior del mentón).
- Realice compresiones y ventilaciones en una relación de **30:2** si es un único reanimador y de **15:2** si son dos reanimadores.

5) SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA)

El Soporte Vital Avanzado (SVA) es el cuarto eslabón de la cadena de supervivencia. Para resumir las principales características del soporte vital avanzado se han agrupado en los siguientes apartados:

5.1) Vía aérea y ventilación: En esta etapa el método de ventilación a preferir será la ventilación pasiva mediante intubación oro traqueal como manejo más adecuado para la vía aérea. Se recomienda el uso empírico de una FiO₂ de 100% tan pronto como sea posible, para conseguir saturaciones mayores a 90%. La frecuencia de ventilaciones será de 1 ventilación cada 6 u 8 segundos (8 a 10 ventilaciones por minuto) sin pausas en las compresiones.

5.2) Accesos Vasculares: La búsqueda de accesos vasculares se iniciará apenas se cuente con personal suficiente para realizar esta técnica sin interrumpir las

compresiones torácicas de alta calidad a través de vías venosas periféricas gruesas, siendo la primera opción los accesos vasculares en las extremidades superiores.

5.3) Tratamiento farmacológico: La administración de vasopresores (Adrenalina) debe administrarse lo antes posible según los algoritmos de paro cardíaco SVCA/ACLS o SVCA/PALS de la American Heart Association (AHA).

Las dosis de adrenalina, frecuencia y tiempos de repetición a seguir se encuentran adjuntos en el algoritmo de las figuras 18 y 19.

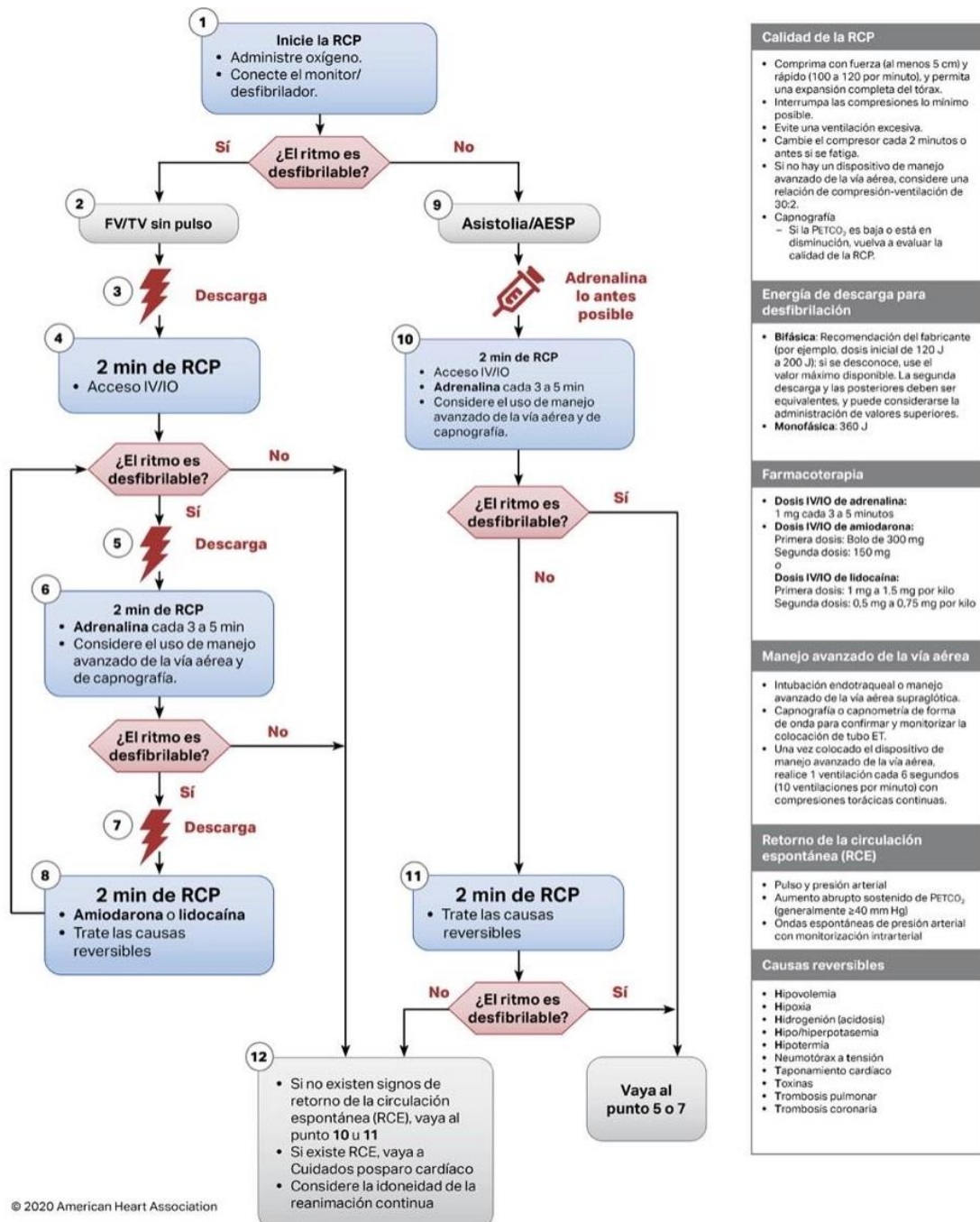
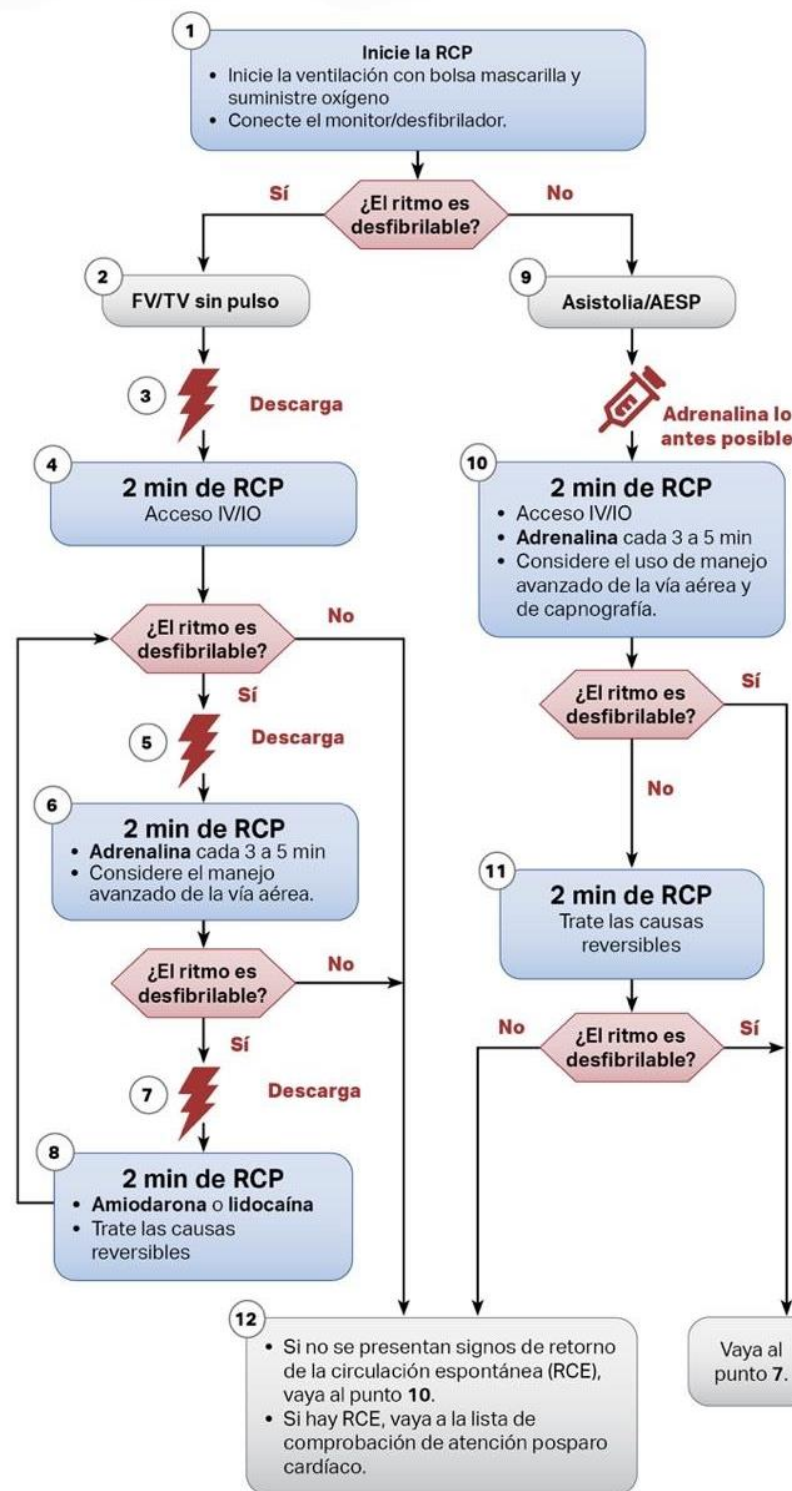


Figura 18: Algoritmo paro cardíaco en adultos



Calidad de la RCP

- Comprima fuerte ($\geq \frac{1}{2}$ del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (de 100 a 120/min) y permita una expansión completa del tórax.
- Reduzca al mínimo las interrupciones entre compresiones.
- Cambie el compresor cada 2 minutos o antes si se fatiga.
- Si no se cuenta con un manejo avanzado de la vía aérea, la relación compresión-ventilación debe ser de 15:2.
- Si se cuenta con un manejo avanzado de la vía aérea, realice compresiones continuas y suministre una ventilación cada 2 a 3 segundos.

Energía de descarga para desfibrilación

- Primera descarga 2 J/kg
- Segunda descarga 4 J/kg
- Descargas posteriores ≥ 4 J/kg, con un máximo de 10 J/kg o la dosis para adultos

Farmacoterapia

- **Dosis IV/IO de adrenalina:** 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 0,1 mg/ml) Dosis máxima de 1 mg. Repita entre cada 3 y 5 minutos. Si no hay acceso IV/IO, puede administrar una dosis endotraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 1 mg/ml)
- **Dosis IV/IO de amiodarona:** Bolo de 5 mg/kg durante el paro cardíaco. Se puede repetir hasta 3 dosis totales para la FV refractaria o TV sin pulso.
- **Dosis IV/IO de lidocaína:** Inicial: Dosis de carga de 1 mg/kg.

Manejo avanzado de la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Capnografía o capnometría de forma de onda para confirmar y monitorizar la colocación de tubo ET.

Causas reversibles

- Hipovolemia
- Hipoxia
- Hidrogenión (acidosis)
- Hipoglucemia
- Hipo/hiperpotasemia
- Hipotermia
- Neumotórax a tensión
- Taponamiento cardíaco
- Toxinas
- Trombosis pulmonar
- Trombosis coronaria

© 2020 American Heart Association

Figura 19: Algoritmo de paro cardíaco pediátrico.

6. ROLES A DEFINIR EN EL PROCESO.

- a. **Líder de equipo:** médico que acude al llamado y organiza al equipo de salud definiendo roles para cada uno.
- b. **Encargado de compresiones:** realizar compresiones según lo explicitado en BLS y se intercambiará con un segundo encargado de compresiones
- c. **Encargado de vía aérea:** Encargado de permeabilizar la vía aérea, entregar oxígeno de ser necesario y preparar vía aérea en una posible IOT
- d. **Encargado de desfibrilador/monitor:** Conectar monitor según indicaciones por el líder además de administrar desfibrilación/cardioversión eléctrica según sea necesario según algoritmo de RCP.
- e. **Encargado de vía venosa:** encontrar 2 vías venosas permeables y administrar medicamentos según indicación del líder.
- f. **Encargado de registro:** registra la administración de fármacos, tiempos de compresiones/ventilaciones y desfibrilaciones según sea el caso, además avisa al líder cuando se cumplen ciclos de reanimación. Los tiempos y registros deben estar a la vista del equipo de reanimación.

7. DEL REGISTRO DE LAS PRESTACIONES.

Toda RCP sea esta exitosa o no, debe contar con un correcto registro, para esto se debe llevar la correcta anotación del procedimiento en la pizarra de la sala de reanimación, siendo cuidadoso en la anotación de los tiempos, de los procedimientos realizados y medicamentos indicados. El Médico por otra parte debe contactar a SAMU para el traslado del paciente y una vez finalizado el procedimiento (RCP) debe traspasar la historia clínica y manejo realizado en hoja de derivación que se llevará el SAMU (quedando una de las hojas autocopiativas como respaldo bajo responsabilidad de enfermera a cargo de unidad) y posteriormente hacer lo mismo en la ficha del paciente en sistema RAYEN.

IX. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Peralillo.
- Unidad de Calidad.
- Equipo SUR
- Sala respiratoria CESFAM.
- Todos los funcionarios/as CESFAM, Postas y EMR.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Gana, D. A. / E. U. (s/f). MANUAL DE RCP BÁSICO Y AVANZADO. Medicina.uc.cl. <https://medicina.uc.cl/wp-content/uploads/2021/04/manual-rcp-basico-avanzado-medicina-uc.pdf>
- Hospital, D., Salvador, S., & De Salud, V.-S. (s/f). Reanimación Cardio Pulmonar Avanzada a pacientes del HDS. Gob.cl. <https://hdsalvador.redsalud.gob.cl/wp-content/uploads/2021/07/GCL-1.2-APLICACION-DE-RCP-EN-ADULTOS-NI%C3%91OS-VERSION-4-VIG-2025.pdf>
- Pincheira, M. A., Miranda, F. A., Alejandra, M., Vidal, G., Gloria, C., Villalobos, P., & Olivares, B. Q. (s/f). HOSPITAL SAN PABLO COQUIMBO PROTOCOLO REANIMACION CARDIOPULMONAR ADULTO. Hospitalcoquimbo.cl. <https://www.hospitalcoquimbo.cl/wp-content/uploads/2021/12/GCL-1.4-Protocolo-de-Reanimacion-Cardiopulmonar-Adulto-version-0.2.pdf>
- Coma-Canella, I., García-Castrillo Riesgo, L., Ruano Marco, M., Loma-Osorio Montes, Á., Malpartida de Torres, F., & Rodríguez García, J. E. (1999). Guías de actuación clínica de la Sociedad Española de Cardiología en resucitación cardiopulmonar. Revista española de cardiología, 52(8), 589–603. [https://doi.org/10.1016/s0300-8932\(99\)74975-4](https://doi.org/10.1016/s0300-8932(99)74975-4)
- Rodríguez Yago MA, Alcalde Mayayo I, Gómez López R, Parias Ángel MN, Pérez Miranda A, Canals Aracil M, et al. Recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 (COVID-19). Resumen ejecutivo. Medicina Intensiva [Internet]. 2020 Dec 1;44(9):566–76. Available from: <https://medintensiva.org/es-recomendaciones-sobre-reanimacion-cardiopulmonar-pacientes-articulo-S0210569120301674>
- Alfaro Contreras, B., & Collao Cruz, V. (2022). MANUAL DE ESTUDIO SOPORTE VITAL BASICO (Vol. 3).

XI. AUTORES

- Carolina Beatriz Tapia Touma, Médico EDF Cesfam Peralillo.
- Laura Carolina Pérez Lucero, Médico EDF Cesfam Peralillo.
- Karolan Fabiana Verdugo Muñoz, Médico EDF Cesfam Peralillo.

XII. CONTROL DE CAMBIOS

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento